



### INFORMATIONS DU PATIENT

|                    |                                                                 |                         |                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Patiente           | Lefebvre, Marie-Claire                                          | Date de naissance       | 03/11/1980 (43 ans)                                                   |
| Adresse            | 18 Boulevard<br>Saint-Germain, 75006 Paris,<br>Île-de-France    | N° Sécurité Sociale     | 2 80 11 75 012 456 78                                                 |
| N° Dossier Patient | LRB-2024-ICU-088213                                             | Médecin responsable     | Dr. Antoine Girard,<br>Réanimateur — Dr. Sophie<br>Blanc, Pneumologue |
| Admission          | 20/09/2024 (Urgences)  <br>Sortie : 28/09/2024 (Service<br>MCO) | Mode de prise en charge | 100 % ALD (Affection de<br>longue durée) — Code 30                    |

### 1 — RÉSUMÉ CLINIQUE POUR CODAGE

Patiente admise aux urgences pour dyspnée aiguë sévère et fièvre à 39,8 °C. Diagnostiquée avec une pneumonie lobaire droite compliquée d'un épanchement pleural para-pneumonique et d'un sepsis sévère avec hypotension réfractaire nécessitant un séjour en réanimation de 4 jours. Germe identifié : Streptococcus pneumoniae sérotype 3. Traitée par drainage pleural, antibiothérapie IV et support vasopresseur.

### 2 — CODES CIM-10 ASSIGNÉS

| ICD-10 Code | Description                                               | Category              | Severity     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| J18.1       | Pneumonie lobaire, sans précision                         | Appareil respiratoire | Principal    |
| J90         | Épanchement pleural                                       | Appareil respiratoire | Associé      |
| A40.3       | Septicémie à Streptococcus pneumoniae                     | Maladies infectieuses | Associé      |
| R65.21      | Sepsis sévère avec choc septique                          | Symptômes généraux    | Complication |
| J96.00      | Insuffisance respiratoire aiguë, hypoxémique              | Appareil respiratoire | Complication |
| R09.02      | Hypoxémie                                                 | Symptômes généraux    | Associé      |
| Z23         | Vaccination contre la pneumonie — statut non vacciné noté | Prévention            | Info         |
| 5A1935Z     | Ventilation mécanique < 24 h (CIM-10-PCS)                 | Procédure             | Procédure    |
| 0W990ZX     | Drainage thoracique percutané (CIM-10-PCS)                | Procédure             | Procédure    |

### 3 — PROCÉDURES ET ACTES EFFECTUÉS

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Thoracocentèse (20/09)        | Drainage de 650 mL d'exsudat sérohématique ; pH 7,18 ; LDH 1240 U/L. |
| Ventilation mécanique (21/09) | Intubation oro-trachéale 18 h pour insuffisance respiratoire aiguë.  |
| Hémocultures x4 (20/09)       | Positives : Streptococcus pneumoniae — sensible à Pénicilline G.     |
| Antibiothérapie IV            | Amoxicilline 2 g x 4/j x 10 j + Azithromycine 500 mg/j x 5 j.        |
| Vasopresseurs                 | Norépinéphrine 0,3 µg/kg/min x 48 h — titration et arrêt progressif. |

4 — GHM (GROUPES HOMOGÈNES DE MALADES) ET CODAGE PMSI

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| GHM principal :         | 04M08V — Pneumonie & pleurésie compliquée, niveau 4 (très sévère)          |
| Niveau de sévérité :    | 4 — Complications majeures / comorbidités (sepsis + ventilation mécanique) |
| DMS observée / prévue : | 8 jours / 6,2 jours (déviation +1,8 j justifiée par la complexité)         |
| DP / DR / DA :          | DP: J18.1   DR: A40.3   DA: J90, R65.21, J96.00                            |

⚠ SYNTHETIC DOCUMENT — All patient data, names, identification numbers and clinical details in this document are entirely fictional and have been generated for AI research purposes. Any resemblance to real persons is purely coincidental. Not for clinical use.